DB

青 岛 市 服 务 业 标 准 规 范

DB 3702/ FW HLBX 007-2020

长期护理保险定点护理服务机构照护服务操作规范

Operational Standards for Care Services of Long-term Care Insurance Designated Care Service

2020-05-29 发布　　2020-06-01 实施

青 岛 市 医 疗 保 障 局　发布
青岛市市场监督管理局

目　　次

目　　次.....1
前　　言.....2
引　　言.....3
1 范围.....4
2 规范性引用文件.....4
3 术语和定义.....4
4 服务操作原则.....4
5 医疗护理服务内容及要求.....5
6 生活照料服务内容及要求.....15
7 康复与功能维护内容及要求.....21
8 其他照护服务内容及要求.....27

前　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由青岛市医疗保障局提出并归口。

本标准起草单位：青岛市医疗保障事业中心、青岛市长期照护协会。

本标准主要起草人：马青、李静、张秋立、唐林凤、邓玉华、林君丽、刘湘源、刘楠、孙源、姜日进、谭美青、张志勤、孙渊、王圆、王莹、刘序田、朱红燕、纪斌 。

引　　言

本标准是《长期护理保险管理与服务》标准体系系列之一，是为护理保险照护人员给失能失智人员进行照护服务时提供规范的操作依据，有利于定点护理服务机构提高照护服务质量。

长期护理保险定点护理服务机构照护服务操作规范

1 范围

本标准规定了长期护理保险定点护理服务机构的服务操作原则、医疗护理服务、生活照料服务、康复与功能维护、其他照护服务等主要内容及要求。

本标准适用于青岛市行政区内的长期护理保险定点护理服务机构照护服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35796-2017 养老机构服务质量基本规范

DB3702/FW HLBX001-2019 长期护理保险管理与服务 总则

3 术语和定义

DB3702/FW HLBX001-2019 界定的术语和定义，以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

医疗护理服务 Medical care services

为失能、失智人员提供疾病预防、治疗、护理、保健等的活动。

注：改写 GB/T 35796-2017，定义 3.2。

3.2

生活照料服务 Living care services

协助或照顾失能、失智人员饮食、起居、清洁、卫生等日常生活的活动。

注：改写 GB/T 35796-2017，定义 3.1

4 服务操作原则

4.1 照护人员应严格按工作权限执行各项操作，禁止越权操作。

4.2 遵医嘱给药，严格执行查对制度。

4.3 无菌操作时，应严格执行无菌技术操作原则。

4.4 给同一照护对象进行多项操作时，应先执行简单操作，再执行复杂操作，最后执行无菌操作。

4.5 对创伤性操作，应严格执行知情同意制度。

4.6 对患有传染病的照护对象，操作时应严格执行消毒隔离原则。

4.7 应注重人文关怀，保护个人隐私。

4.8 应遵循节力原理，加强照护人员个人防护，避免损伤。

5 医疗护理服务内容及要求

5.1 医疗护理服务内容

5.1.1 医疗护理服务内容包括但不限于：生命体征监测、皮下注射、静脉注射、皮内注射、肌肉注射、静脉采血、动脉采血、静脉留置针穿刺、尿标本采集、粪便标本采集、伤口换药、叩背排痰、雾化吸入、吸痰护理、胃管置入、胃管进食护理、口腔护理、留置导尿、膀胱冲洗、留置导尿护理、尿潴留护理、灌肠、物理降温、口服给药、眼耳鼻给药、阴道给药、直肠给药、皮肤外涂药、造瘘口护理、经外周静脉置入中心静脉导管PICC维护、噎食急救、心肺复苏。

5.1.2 本标准5.1.1的服务内容应由执业护士完成，其中生命体征监测、尿标本采集、粪便标本采集、叩背排痰、胃管进食护理、口腔护理、留置导尿护理、物理降温、眼耳鼻给药、口服给药、皮肤外涂药、造瘘口护理、噎食急救、心肺复苏等项目，可由护理员在护士的指导下完成。

5.2 医疗护理服务操作要求

5.2.1 生命体征监测

生命体征监测包括监测体温、脉搏、呼吸及血压等，具体操作要求如下：

a）体温监测：体温计消毒方法应符合要求。测腋温、口温、肛温时，应选择适合相应部位的体温计，注意将体温计放置在正确的位置，按规定的时间进行测量。对老年失智、精神异常、意识不清、烦躁和不合作者，应采取恰当的测量方法或在床旁协助测量体温。

b）脉搏监测：应选择合适的部位，测量时间一般为 30 秒，脉搏异常时应测量 1min。避免在偏瘫、动静脉瘘、手术等肢体测量。

c）呼吸监测：测量呼吸时应注意观察呼吸频率、节律、类型等情况，取自然体位，观察胸部或腹部起伏，测量时间一般为 30 秒，呼吸异常时应测量 1min。

D）血压监测：应选择合适的血压计。协助照护对象采取坐位或仰卧位，保持血压计零点、肱动脉与心脏同一水平。选择宽窄度适宜的袖带，驱尽袖带内空气，平整地缠于照护对象上臂中部，松紧以能放入一指为宜，下缘距肘窝 2～3cm。正确判断收缩压与舒张压。如血压听不清或有异常时，应间隔 1～2min 后重新测量。长期观察血压的照护对象，应定时间、定部位、定体位、定血压计。

5.2.2 皮下注射

5.2.2.1 应严格执行查对制度、无菌操作技术原则、安全给药原则。

5.2.2.2 应评估了解照护对象患病情况、药物过敏史、用药史及注射部位皮肤和皮下组织状况,皮下注射用物应准备齐全。

5.2.2.3 应核对药物及照护对象身份信息。协助取适当体位，暴露注射部位。消毒皮肤，绷紧皮肤或捏起局部组织，穿刺，抽回血，确认无回血后缓慢推注药液。快速拔针，棉签轻压片刻。注意进针角度不得大于 45 度。

5.2.2.4 注射后勿揉搓注射部位，长期皮下注射者，应有计划地更换注射部位，防止局部产生硬结。

5.2.2.5 皮下注射胰岛素时，应注意胰岛素剂型和照护对象进食时间的要求。预混胰岛素应摇匀后注射。

5.2.3 静脉注射

5.2.3.1 参见本标准 5.2.2.1。

5.2.3.2 应评估了解照护对象病情、药物过敏史、用药史及注射部位皮肤和静脉组织状况，静脉注射用物应准备齐全。

5.2.3.3 应严格核对药物及照护对象身份信息。协助取适当体位，暴露穿刺部位。选择合适静脉，在穿刺部位的肢体下垫小枕，在穿刺点上方约 6cm 处扎紧止血带，止血带末端向上，消毒皮肤，嘱照护对象握拳使静脉充盈。排尽空气后，左手拇指绷紧静脉下端皮肤，使其固定，右手持注射器，针头斜面向上，食指固定针栓，针头与皮肤呈 20° 角，由静脉上方或侧方刺入皮下，再沿静脉方向潜行刺入，见回血后再顺静脉进针少许。松止血带，嘱照护对象松拳，缓慢推药液。

5.2.3.4 注射过程中，应密切观察照护对象反应，必要时试抽回血。

5.2.3.5 注射完毕，应以干棉签按压血管穿刺处皮肤，迅速拔出针头，局部压迫片刻，以免出血。再次查对。

5.2.4 皮内注射

5.2.4.1 参见本标准 5.2.2.1。

5.2.4.2 应评估了解照护对象病情、药物过敏史、用药史及注射部位皮肤状况。如照护对象对需要注射的药物有过敏史，则不能作皮试，应和医生取得联系，更换其他药物后再作试验。皮内注射用物应准备齐全。

5.2.4.3 应严格核对药物及照护对象身份信息等。消毒皮肤，排尽注射器内空气，左手绷紧前臂内侧皮肤，右手持注射器，使针尖斜面向上，与皮肤呈 5° 角刺入皮内。待针头斜面完全进入皮内后，放平注射器，左手拇指固定针栓，右手推注药液 0.1ml，使局部隆起成半球状的皮丘，皮丘皮肤变白，并显露毛孔。

5.2.4.4 注射 20min 后应观察结果，注意病情观察。如需作对照试验，须用另一注射器和针头，在另一前臂相同部位，皮内注射等渗盐水 0.1ml，20min 后对照观察反应。

5.2.4.5 过敏试验忌用碘酊消毒，以免因脱碘不彻底而影响对局部反应的观察，且易和碘过敏反应混淆。

5.2.5 肌肉注射

5.2.5.1 参见本标准 5.2.2.1。

5.2.5.2 应评估照护对象病情、过敏史、用药史，以及注射部位皮肤情况。告知照护对象药物名称及注意事项，取得照护对象配合。肌肉注射用物应准备齐全。

5.2.5.3 应严格核对药物及照护对象身份信息等。协助取适当体位，暴露注射部位，注意保护隐私。消毒皮肤，一手绷紧皮肤，一手持注射器，针尖与皮肤垂直，快速进针刺入肌内。确认无回血后缓慢注入药液。注射完毕，快速拔针，棉签轻压进针处片刻。

5.2.5.4 应选择合适的注射器及注射部位，需长期注射者，应有计划地更换注射部位。需要两种药物同时注射时，应注意配伍禁忌。

5.2.6 静脉采血

5.2.6.1 应严格执行无菌操作技术原则。核对医嘱，静脉采血用物准备齐全。

5.2.6.2 应评估照护对象病情、意识状态、穿刺部位皮肤状况、静脉充盈度、血管壁弹性及肢体活动度。向照护对象解释静脉采血的目的及穿刺方法，取得配合。

5.2.6.3 应根据检验项目选择采血试管。使用一次性采血针，按操作规程进行穿刺，见回血后，按顺序依次插入采血试管，含有添加剂的采血管在血液采集后立即轻轻混匀。按压穿刺部位 1～2min，凝血机制差的照护对象应延长至 10 min。

5.2.6.4 禁止从输液、输血侧肢体采血。标本采集后应尽快送检，送检过程中避免过度震荡。

5.2.7 动脉采血

5.2.7.1 应严格执行无菌操作技术原则。核对医嘱，动脉采血用物准备齐全。

5.2.7.2 应评估照护对象病情、意识状态、穿刺部位皮肤状况、动脉搏动等情况。了解照护对象吸氧状况或者呼吸机参数的设置。向照护对象解释动脉采血的目的及穿刺方法，取得照护对象配合。

5.2.7.3 选取合适注射器，抽取适量肝素抗凝剂，转动活塞使肝素均匀附着于整个注射器内，针尖向上推出多余液体和残留的空气。（也可用动脉血气穿刺针直接抽取。）

5.2.7.4 应消毒穿刺部位，确定动脉及走向后，迅速进针，动脉血自动顶入血气针内，一般需要 1ml 左右。拔针后应立即将针尖斜面刺入橡皮塞或者专用凝胶针帽隔绝空气。将血气针轻轻转动，使血液与肝素充分混匀，立即送检。应协助照护对象垂直按压穿刺部位 5-10min。

5.2.7.5 应指导照护对象放松、平静呼吸，避免影响血气分析结果。告知照护对象正确按压穿刺点，并保持穿刺点清洁、干燥。若照护对象饮热水、洗澡、运动，应休息 30min 后再取血，避免影响检查结果。做血气分析时注射器内勿有空气。有出血倾向的照护对象慎用。

5.2.8 静脉留置针穿刺

5.2.8.1 应严格执行无菌操作技术原则。核对医嘱，静脉留置针穿刺用物准备齐全。

5.2.8.2 应了解照护对象患病情况及合作程度，评估其意识状态、药物过敏史及用药史，评估穿刺点皮肤、静脉充盈度、血管壁弹性及肢体活动度。

5.2.8.3 应协助取舒适体位，选择型号适宜的留置针，选择粗直、弹性好、易于固定的静脉，避开关节和静脉窦。穿刺部位下垫巾，穿刺点上方 8～10cm 处扎止血带。消毒皮肤，留置针与皮肤呈 15° ～30° 角直刺静脉，见回血后再进入少许，将针芯后撤少许后将导管全部送入，松开止血带，撤出全部针芯，连接无针输液装置。透明敷料以穿刺点为中心妥善固定，延长管与穿刺血管呈 U 型固定，肝素帽及 Y 型接口进行适当固定，注明置管日期及时间。根据药物性质及病情需要调节滴速。

5.2.8.4 应尽量避免在下肢静脉穿刺。出汗多、局部有出血或渗血时，应及时更换敷料。发生穿刺点红肿、管路堵塞时，应拔管重新穿刺。

5.2.9 尿标本采集

5.2.9.1 留取尿标本时应评估照护对象患病情况、意识状态及排尿情况。不应留取集尿袋中的尿液标本送检，不可混入粪便及其他杂物。尿标本采集用物准备齐全。

5.2.9.2 留取普通尿标本时，应留取清晨第一次尿液的中段尿，按要求放入清洁容器内。

5.2.9.3 留取 24h 尿标本时，应选择清洁的大容量容器，协助照护对象早晨 7 点排空膀胱后开始留尿，至次日早晨 7 点留取最后一次尿液。

5.2.9.4 留取尿培养标本时，对未留置尿管者，应用清水充分清洗会阴部，再用生理盐水或灭菌用水冲洗尿道口，若男性包皮过长，应将包皮翻开冲洗，弃去前段尿，留取中段尿 10～15ml，置于无菌容器内；对留置尿管者，应先夹闭尿管 30s，消毒尿管外部及尿管口，用注射器通过尿管抽取尿液，防止带入消毒剂。

5.2.10 粪便标本采集

5.2.10.1 留取粪便标本时应评估照护对象患病情况、意识状态及排便情况。标本内不可混入尿液及其他杂物。粪便标本采集用物准备齐全。

5.2.10.2 对能自主排便的照护对象，应留取粪便中央部分或含有黏液、脓血部分的标本，置于容器内。

5.2.10.3 对无法排便者，应将肛拭子前端用甘油或生理盐水湿润，插入肛门4～6cm处，轻轻在直肠内旋转后取出，置于容器内。

5.2.10.4 进行大便潜血试验者，应嘱照护对象检查前3天内禁食铁剂及肉类、肝类、血类及大量叶绿素食物，第4天采集标本。

5.2.11 伤口换药

5.2.11.1 严格执行无菌技术操作原则，换药用物准备齐全。

5.2.11.2 换药前，应评估照护对象患病情况、意识状态、伤口形成原因、持续时间、曾接受的治疗及护理等。观察伤口的部位、大小（长、宽、深）、潜行、组织形态、渗出液、颜色、感染状况、伤口周围皮肤或组织状况等。

5.2.11.3 换药时，应协助照护对象取舒适体位，暴露换药部位，保护隐私。换药过程中应注意保暖，密切观察病情，出现异常情况及时报告医生。

5.2.11.4 取下伤口敷料时，若敷料与伤口粘连，应用生理盐水浸湿软化后缓慢取下。

5.2.11.5 清洗伤口时，应选择合适的伤口清洗剂清洁伤口。去除异物、坏死组织等。

5.2.11.6 有多处伤口时，应先换清洁伤口，后换感染伤口。清洁伤口换药时，应从伤口中间向外消毒；感染伤口换药时，应从伤口外向中间消毒。

5.2.11.7 换药后，应清理用物，交待有关注意事项，如需包扎伤口，注意包扎松紧适宜。根据伤口渗出情况确定伤口换药频率。

5.2.12 叩背排痰

5.2.12.1 应评估照护对象意识状态、咳嗽能力及影响咳痰的因素，评估双肺呼吸音及痰液情况。有活动性内出血、咯血、气胸、肋骨骨折、肺水肿、严重骨质疏松等，禁止背部叩击。

5.2.12.2 扣背时，照护人员的手指应并拢弯曲，拇指紧靠食指，手呈握杯状，以手腕力量有节律地叩击，每次叩击10min左右，促进排痰。拍背顺序应从下至上、从外至内、背部从第十肋间隙、胸部从第六肋间隙开始向上叩击至肩部。注意避开乳房及心前区，力度适宜。

5.2.12.3 扣背过程中，应密切观察扣背排痰效果，及时清除口鼻分泌物。

5.2.12.4 给照护对象翻身时，应妥善处理各种管路，避免拖、拉、拽等动作。

5.2.13 雾化吸入

5.2.13.1 应选择整洁、温湿度适宜的室内环境。评估照护对象的年龄、病情、意识状态，有无呼吸困难、咳嗽等情况。雾化吸入用物准备齐全，部分用物专人专用。

5.2.13.2 应严格执行查对制度，遵医嘱核对加药。

5.2.13.3 应协助照护对象取舒适体位，用氧气雾化吸入法、超声雾化吸入法等方法进行雾化吸入，严密观察全过程，如呼吸困难、紫绀、疲劳时，关闭雾化器，休息片刻再进行，有痰时协助排出。

5.2.13.4 雾化吸入结束后，应取下雾化器，清理消毒用物。氧气雾化吸入时，注意严格执行“四防”。

5.2.14 吸痰护理

5.2.14.1 严格执行无菌技术操作原则。吸痰用物准备齐全。

5.2.14.2 应评估照护对象的病情、意识，痰液性质、量及颜色，配合程度，双肺呼吸音，口腔及鼻腔有无损伤等，

5.2.14.3 应检查吸引器性能及呼吸机参数设置。调节负压在 0.02～0.04MPa 范围内。选择型号适宜的吸痰管，吸痰管外径应小于人工气道内径的 1/2，插管长度应根据年龄和病情进行调整，其中气管插管插入长度约 20～25cm，气管切开插入长度约 12～13cm。

5.2.14.4 经口鼻吸痰时，应将吸痰管经口或鼻腔插入气道，吸痰过程中边旋转边向上提拉，吸痰结束后应冲洗负压管道。需再次吸痰时应更换吸痰管。

5.2.14.5 经人工气道吸痰时，吸痰前后应给予 2min 纯氧。将吸痰管迅速、准确送入人工气道内，深度适宜，边旋转边向上提拉吸痰管。

5.2.14.6 吸痰时间应不超过 15s/次。如需反复吸痰，重复吸引应不超过 3 次，中间应间隔 3min。

5.2.14.7 吸痰后应及时记录痰液的颜色、量及性状，监测血氧饱和度变化，注意观察生命体征、气道是否通畅及照护对象的反应等。

5.2.14.8 每次吸痰均应更换吸痰管，先吸气道分泌物，再吸口鼻处。吸痰应动作轻稳，防止呼吸道黏膜损伤。吸痰过程中心率明显减慢或血氧饱和度下降至 90%以下，应立即停止吸痰，并给予高浓度氧气吸入。

5.2.15 胃管置入

5.2.15.1 应评估照护对象病情，意识状态，口腔、鼻腔黏膜及插管周围皮肤情况。胃管置入用物准备齐全。

5.2.15.2 置管前，应协助照护对象取下活动义齿。根据病情取合适体位。清洁鼻腔，测量插入胃管长度（从鼻尖经耳垂至胸骨剑突处的距离或前额发际至剑突处）。戴手套，涂抹润滑剂于纱布上，再涂抹于胃管前部。将胃管缓缓插入，到咽喉部（插入 10～15cm）时，嘱照护对象做吞咽动作，随吞咽动作插入胃管至预定长度。

5.2.15.3 证实胃管是否在胃内，方法包括抽取胃液法、听气过水声法、将胃管末端置于盛水的治疗碗中有无气体逸出。妥善采取二次固定，并做好标记。

5.2.15.4 如插管过程中出现恶心、呛咳、呼吸困难及发绀时，应立即拔出，休息后重新插入。长期留置胃管者，应定期更换胃管，更换胃管时如无特殊情况应选取另一侧鼻腔插入。

5.2.16 胃管进食护理

5.2.16.1 应评估照护对象病情、胃管留置时间、意识状态、腹痛、腹胀、恶心、胃潴留、排便及营养状况。评估进食液的温度及性状。

5.2.16.2 进食前，应协助照护对象取坐位或半坐位，无法坐起者摇高床头 30 度，取右侧卧位。判断胃管在胃内，注入 20ml 温开水，观察管道通畅，缓慢注入进食液，速度为 10～13ml/min，进食后注入 50ml 温开水，冲净胃管食物残渣并妥善固定。保持进食体位 30min，避免呕吐和误吸。

5.2.16.3 每次进食量应不超过 200ml，间隔时间应大于 2 小时，饮食温度为 38～40℃。进食过程中，发现恶心、呕吐等情况,应立即停止进食并报告医生。

5.2.16.4 对长期置胃管的照护对象，应每日早、晚间做口腔护理,保持口腔清洁。

5.2.16.5 对需要吸痰的照护对象,应在进食前 30min 或后 30min 进行，以避免引起胃液或食物返流及误吸。

5.2.16.6 长期置胃管照护对象需要服用药物时,为防止胃管堵塞,应将片剂研碎、溶解后再灌注。研

碎溶解前应征得医生同意。

5.2.16.7 应随时观察胃管固定处皮肤的情况。抽吸胃液时若发现胃液内含有血液或咖啡样物等异常，应立即报告医生。

5.2.17 口腔护理

5.2.17.1 应评估照护对象的病情、意识、配合程度，观察口腔黏膜有无异常，有无活动义齿。口腔护理用物准备齐全。

5.2.17.2 应向照护对象解释操作目的，取得配合，遵医嘱选择合适的口腔护理液，协助照护对象取下活动义齿。

5.2.17.3 应协助照护对象取合适体位，按要求依次擦洗口唇，由内向外擦洗牙齿外侧面、内侧面、咬合面，颊部、硬腭、舌面及舌下等部位。

5.2.17.4 操作前后应清点棉球，数量一致，操作中，应用弯血管钳夹紧棉球，防止遗留在口腔内。使用的棉球不宜过湿，以不滴水为宜，防止引起呛咳。昏迷或意识模糊的照护对象禁止漱口，避免水分流入咽部引起呛咳。使用开口器时，应从臼齿处放入。擦洗时注意勿触及咽部，以免引起恶心等不适。

5.2.18 留置导尿

5.2.18.1 应严格执行无菌技术操作原则。操作前留置导尿用物准备齐全。

5.2.18.2 应评估照护对象病情、意识状态、合作程度、排尿情况、会阴情况及膀胱充盈度，男性照护对象还应了解有无前列腺病史。

5.2.18.3 操作时，应协助照护对象取屈膝仰卧位，两腿略外展，用软垫支撑，暴露外阴，注意保暖及保护隐私。

5.2.18.4 清洗外阴，应按无菌操作要求消毒外阴及尿道口。戴无菌手套，铺孔巾，检查导尿管，气囊导管应检查尿管气囊是否漏气，连接尿管与集尿袋，润滑尿管前端。

5.2.18.5 再次按无菌技术操作原则消毒尿道口，应将尿管插入尿道。普通导尿管女性插管长度约 5～7cm，男性约 22～24cm；气囊导尿管女性插管长度约 10～12cm，男性约 26～28cm。

5.2.18.6 应根据尿管上注明的气囊容积向气囊注入等量的无菌溶液，轻拉尿管确认有阻力。固定尿管及集尿袋，注明留置尿管的日期及时间。

5.2.18.7 插管遇阻力时，切忌强行插入。女性照护对象尿道口回缩，插管时应仔细观察，避免误入阴道。误入阴道时，需更换尿管重插。照护对象发生尿潴留进行导尿，第一次排尿量不应超过 1000ml，避免腹内压急剧下降引起膀胱出血。

5.2.19 膀胱冲洗

5.2.19.1 应评估照护对象尿液、出血、排尿不适等情况。膀胱冲洗用物准备齐全。

5.2.19.2 应将膀胱冲洗液悬挂在输液架上，液面高于床面约 60cm，连接前各接头进行消毒。冲洗速度 60～80 滴/min，待照护对象有尿意或滴入 200～300ml 后夹闭冲洗管，排出冲洗液，遵医嘱反复进行。

5.2.19.3 冲洗时，应注意照护对象反应，观察冲洗液出入量、颜色和有无不适。

5.2.20 留置导尿护理

5.2.20.1 应每日早、晚清洁会阴部，消毒尿道口；应定期更换集尿袋、导尿管，集尿袋及引流管的位置应该低于耻骨联合，防止尿液逆流，必要时做尿常规化验，防止尿路感染。膀胱有感染者及时

进行膀胱冲洗。

5.2.20.2 应保持尿管通畅，更换体位时应妥善固定导尿管，防止导尿管及连接管扭曲折叠。

5.2.20.3 应观察尿液引流情况，记录 24 小时引流尿液的颜色、性状和量，发现不通畅、漏尿、尿液异常等应及时报告医生。

5.2.20.4 集尿袋中的尿液超过 1/2 应及时排出，避免尿液反流。

5.2.20.5 应协助照护对象多饮水、更换体位，身体状态允许下，每日饮水量 2000 到 2500ml（包括食物内的水分）。

5.2.20.6 对膀胱功能尚好的长期留置导尿管者应训练膀胱反射功能，作间歇性夹管和引流，每 3-4 小时开放一次，使膀胱定时充盈和排空，必要时每 2 小时开放一次。应用利尿剂照护对象，必要时每 30min 开放排尿一次。

5.2.21 尿潴留护理

5.2.21.1 应做好心理疏导,改善紧张状态,放松情绪。

5.2.21.2 如卧位排尿困难时,应注意改变体位，协助采取坐位或立位引起排尿。

5.2.21.3 用温热毛巾热敷下腹部、用温水冲洗会阴部或以流水声等方法刺激排尿。

5.2.21.4 用手轻轻左右推揉膨隆的膀胱 10～20 次，或者从膀胱底部向下推移按压 1～3min，如有尿液排出,继续按压,待尿液排空后再停止。按摩排尿时应注意用力轻柔均匀，切忌用力过猛而损伤膀胱。有高血压病、腹腔及盆腔肿瘤者禁用按摩排尿法。

5.2.21.5 以上护理措施无效时，应选择留置导尿，留置导尿操作要求参见本标准 5.2.18。

5.2.22 灌肠

5.2.22.1 应评估照护对象的意识、情绪、排便情况及肛门周围皮肤黏膜状况。根据照护对象病情选择灌肠方式，灌肠用物准备齐全。

5.2.22.2 应根据不同的灌肠方法准备灌肠液，温度适宜。按要求取合适体位，注意保暖及保护照护对象隐私。

5.2.22.3 润滑肛管前段，排除管道气体，指导照护对象深呼吸。

5.2.22.4 不保留灌肠时，灌肠袋液面距肛门高度 40～60cm。保留灌肠时，液面至肛门的高度应低于 30cm。不保留灌肠、甘油灌肠插入肛内长度约 7～10cm，保留灌肠插入肛内长度约 15～20cm。

5.2.22.5 固定肛管，使灌肠液缓缓流入，根据照护对象反应调节速度。灌肠完毕后应将肛管拔出，擦净肛门。根据不同的灌肠方法，保留适宜的时间后排便。

5.2.22.6 消化道出血、急腹症、严重心脏病、直肠、结肠和肛门手术后及大便失禁者，不宜灌肠。肝性脑病者禁用肥皂水灌肠。充血性心力衰竭照护对象禁用 0.9%氯化钠溶液灌肠。灌肠过程中出现脉搏细速、面色苍白、出冷汗、剧烈腹痛、心慌等症状时，应立即停止，并报告医生。保留灌肠时，肛管宜细，插入宜深，速度宜慢，量宜少，保留时间宜长，防止气体进入肠道。

5.2.23 物理降温

5.2.23.1 应评估照护对象病情、意识、局部组织灌注情况、皮肤情况、配合程度、有无酒精过敏史。

5.2.23.2 应遵医嘱选择合适的物理降温方法（使用冰袋、酒精擦浴、温水擦浴等）。半小时后应复测照护对象体温，并及时记录体温和病情的变化。

5.2.23.3 实施物理降温时应观察局部血液循环和体温变化情况。重点观察照护对象皮肤状况，如照护对象发生皮肤苍白、青紫或者有麻木感时，应立即停止使用，防止冻伤。物理降温时，应避开照

护对象的枕后、耳廓、心前区、腹部、阴囊（男性）及足底部位。

5.2.23.4 擦浴时，应在头部放置冰袋，防止表皮血管收缩引起头部充血导致头痛；脚下应放置热水袋，促进足底血管扩张有利散热。冰袋和热水袋应用袋套或用毛巾包裹，昏迷等感觉功能障碍者使用热水袋时，水温不宜超过 50℃。

5.2.24 口服给药

5.2.24.1 应严格执行查对制度，遵医嘱给药。应评估照护对象的病情、过敏史、用药史、不良反应史。了解照护对象所服药物的作用、不良反应以及某些药物服用的特殊要求，如有疑问应核对无误后方可给药。

5.2.24.2 服药时应尽量让照护对象取坐位或半坐卧位，以利药物进入胃内。一般服药用水量以每 2～4 片准备 100ml 温水为宜。服药时不可与茶水一起服用，服药时速度适宜，必要时碾碎喂服。

5.2.24.3 为留置胃管照护对象给药时，应将药物研碎溶解后由胃管注入。注意观察照护对象的服药效果及不良反应。

5.2.25 眼部给药

5.2.25.1 严格执行查对制度，遵医嘱给药。用物准备齐全。应评估照护对象病情，选择清洁，温湿度适宜的环境。

5.2.25.2 应协助照护对象取半坐位，清洁照护对象眼部后，距离眼睛 3cm 处，每次 1-2 滴，将药液点入下结膜囊内，嘱照护对象闭眼，眼球转动，使药液充盈在结膜内。压住泪囊数分钟，阻断药水随鼻泪管流入鼻腔，保证眼睛局部有效药物浓度。

5.2.25.3 眼部给药后，应取棉棒轻轻按摩照护对象左、右上眼睑，并擦去眼部溢出的药液，观察用药反应。

5.2.25.4 忌将眼药水直接点在眼角膜上，以免刺激产生反射性闭眼，使药液溢出。眼部用药应专人专用，按要求保存。

5.2.25.5 两侧眼睛同时用药时，应遵循先轻后重，先健侧，后患侧的原则。

5.2.26 耳部给药

5.2.26.1 参见本标准 5.2.25.1。

5.2.26.2 应协助照护对象取半卧位，清洁耳道后，向后上方轻轻牵拉耳廓，使耳道变直，将药液沿耳道后壁滴入耳道内 5～10 滴，滴耳剂瓶口不能碰到耳道皮肤。轻压耳屏，使药液充分进入中耳，保持体位 10min。询问并观察有无不适。

5.2.26.3 滴耳剂应专人专用。耳聋、耳道不通或耳膜穿孔时，不应使用滴耳剂。

5.2.27 鼻部给药

5.2.27.1 参见本标准 5.2.25.1。

5.2.27.2 应协助照护对象取平卧位，清洁鼻腔后，协助头部后仰，嘱照护对象吸气、屏住，向鼻腔内滴入药液 3～4 滴，滴鼻剂瓶口不能碰到鼻粘膜，滴药后保持仰位 1～2min，以利于药物吸收。轻柔两侧鼻翼，使药液均匀渗入鼻粘膜。询问并观察有无不适。若药液流入口腔，应协助将其吐出。

5.2.27.3 滴鼻剂应专人专用，按要求保存。

5.2.28 阴道给药

5.2.28.1 参见本标准 5.2.25.1。

5.2.28.2 应评估照护对象意识状态、药物过敏史及用药史。评估周围环境温度，注意保暖、保护隐私。

5.2.28.3 应协助照护对象取截石位，充分暴露会阴部，臀下垫垫巾。清洁照护对象会阴部、阴道后，进行给药。

5.2.29 直肠给药

5.2.29.1 参见本标准 5.2.25.1。

5.2.29.2 参见本标准 5.2.28.2。

5.2.29.3 直肠给药时，应协助照护对象取左侧卧位，膝部弯曲，暴露肛门。戴上指套或手套，将栓剂沿直肠壁向脐部方向送入 6～7cm，确保药物放置在肛门括约肌以上。嘱照护对象在给药时应放松，深呼吸。用药后应协助照护对象保持侧卧位 15min。

5.2.29.4 直肠活动性出血或腹泻者，不宜直肠给药。

5.2.30 皮肤外涂药

5.2.30.1 应评估照护对象病情、合作程度、意识状态、药物过敏史及用药史。观察皮肤情况。评估环境的温度，注意保暖、保护隐私。

5.2.30.2 皮肤外涂药时，应协助照护对象取合适体位，充分暴露用药部位。清洁局部皮损，清除原有药液、血迹、体液及分泌物。应根据皮肤受损面积确定药量。将药物均匀涂于皮肤表面，涂药后应适当保持体位 5～10min，以利药物吸收。

5.2.30.3 局部出现红肿及过敏反应时，应立即停止给药，并祛除皮肤上的残留药物。

5.2.31 造瘘口护理

5.2.31.1 应评估照护对象的心理情况，造口及周围皮肤情况，房间温度及隐蔽性。造瘘口护理用物准备齐全。

5.2.31.2 应协助照护对象取舒适体位，暴露造口部位，注意保暖及保护隐私。一手固定造口底盘周围皮肤，一手由上向下分离造口底盘，观察排泄物性状。应用温水由外向内清洁造口及周围皮肤。测量造口大小、形状。修剪造口底盘，必要时可涂造口粉、保护膜及防漏膏。应撕去粘贴面上的纸，按照造口位置由下而上将造口袋底盘贴上，并夹闭造口袋下端开口。应将造口袋与底盘扣紧，沿造口袋连接环在其左、右二点轻压扣合，两指捏紧锁扣。

5.2.31.3 使用造口辅助用品前应阅读产品说明书或咨询造口治疗师。移除造口袋时应注意保护皮肤，粘贴造口袋前应注意造口周围皮肤清洁干燥。造口底盘与造口黏膜之间保持 1～2mm 空隙。应定期扩张造口，防止狭窄。

5.2.32 经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）维护

5.2.32.1 进行 PICC 维护操作的执业护士应经过专业培训。

5.2.32.2 应评估照护对象意识状态，观察 PICC 穿刺时间、穿刺点周围皮肤情况、导管置入及外露长度。

5.2.32.3 打开 PICC 换药包，应以无菌方式取出治疗巾，在置管侧肢体下铺治疗巾。测量双侧肘横纹上方 10cm 处臂围，与置管前臂围对比。

5.2.32.4 揭开固定输液接头的胶布，用 75%酒精清除导管及接头下皮肤胶痕。消毒双手，戴清洁手套，取出预充式导管冲洗器或注射器，安装输液接头，排气备用。卸下旧接头，用 75%酒精消毒导管口，擦拭 15s，待干，连接输液接头与预充式导管冲洗器（或注射器）。抽回血，用预充式导管冲洗器或生理盐水脉冲式冲洗导管，进行正压封管。由导管远心端向近心端除去原有透明敷料，防止导管脱出体外。

5.2.32.5 消毒双手，戴无菌手套。用 75%酒精消毒穿刺点周围皮肤 3 遍，避开穿刺点，消毒直径为 15cm 并大于贴膜面积，充分待干。用 2%葡萄糖酸氯己定乙醇溶液消毒穿刺点及周围皮肤 3 遍，充分待干。调整导管位置，预摆放导管固定装置，涂抹皮肤保护剂并待干，安装导管固定装置。以穿刺点为中心，透明敷料下缘对齐导管固定装置下缘，塑形透明敷料，边按压边去除纸质边框。用无菌胶带固定导管。

5.2.32.6 应按要求填写 PICC 维护手册及 PICC 维护记录单。

5.2.32.7 禁止使用小于 10ml 的注射器冲封管及给药。遇到阻力或抽吸无回血时，应检查导管的通畅性，不可强行冲洗导管。连续输液，每 24h 进行冲管。连续 24h 输液、输注肠外营养液及血液制品结束后，须手动脉冲式冲洗导管。输液结束、输全肠外营养液及抽回血后需立即冲管。涂抹皮肤保护剂时，沿一个方向单层涂抹。非抗高压 PICC 导管不应用于高压注射泵推注造影剂，不应在置管侧肢体测量血压和静脉穿刺。

5.2.33 噎食急救

5.2.33.1 海姆利克急救法

5.2.33.1.1 照护对象坐位发生噎食，意识存在，应迅速协助站立，头部略低，嘴巴张开，站在照护对象背后,两手臂环绕腰部，一手握拳,将拇指侧置于胸廓下和肚脐上的腹部，另一手置于其上，向内、向上、快速、反复、有节奏地、适当用力冲击性地按压腹部,以形成的气流把异物冲出。

5.2.33.1.2 照护对象躺倒在地或在床，意识丧失，应迅速协助取仰卧位,两腿左右分开面对照护对象,迅速骑跨于髋部两侧，双膝跪地或跪床，两手掌重叠,十指相扣,手掌根置于剑突、肚脐连线中间腹部,用上身发力,向内向上、快速、反复、有节奏、适当用力地冲击推压腹部,直至堵塞物排出，如看到阻塞物进入口腔,迅速用食指或中指抠出。

5.2.33.1.3 推压冲击动作应适当用力，避免造成肋骨骨折或内脏损伤。

5.2.33.1.4 发生呼吸心跳骤停时，应立即进行心肺复苏。

5.2.33.2 背部叩击急救法

5.2.33.2.1 照护对象坐位发生噎食，意识存在，应立即呼叫他人协助，照护人员迅速坐在椅子上，使照护对象张口，头部向下，俯卧在照护人员双大腿上，一手扶住照护对象对侧肩部，一手掌根快速、反复、有节奏、用力拍击双肩胛骨中间脊柱部位,直至堵塞物排出。

5.2.33.2.2 照护对象卧位发生噎食，意识丧失，应迅速转移照护对象体位，使头胸部位于床边下方，张口，一手托住胸肩部，另一手掌根快速、反复、有节奏、用力拍击双肩胛骨中间脊柱部位,直至堵塞物排出。

5.2.33.2.3 实施背部叩击急救法，应注意保护，避免跌倒或坠床，保证照护对象安全。

5.2.33.2.4 参见本标准 5.2.33.1.4。

5.2.34 心肺复苏

5.2.34.1 发现照护对象突然意识异常时，应立即轻拍其双肩,并对其大声呼唤,用右手食指和中指并拢触摸颈动脉检查搏动情况，眼睛看向胸部，感觉、观察有无呼吸，时间不超过 10 秒，如发现照护对象意识丧失且无呼吸无脉搏,应立即实施心肺复苏术，同时要求周围人员帮助呼叫医护人员或者拨打“120”急救电话。如有外伤出血存在,同时请人协助止血。如旁边无人应先对患者进行心肺复苏，同时拨打“120”急救电话，电话放免提。

5.2.34.2 应立即使照护对象平卧于硬表面上（地面或胸腹下垫按压板），撤去枕头，置于足下，松

开领口、领带、腰带，暴露胸腹部。

5.2.34.3 应跪在或站在照护对象右侧,两膝分开，开始胸外按压，找准正确按压部位，保证按压力量、速度和深度。开放气道，清理口腔分泌物，如有活动假牙需取出，进行口对口人工呼吸。心脏按压与人工呼吸比例应为 30：2，每 5 个循环应检查一次生命体征是否恢复，直到意识恢复或专业急救人员到达。

5.2.34.4 专业急救人员到达现场后,照护人员应汇报病情及抢救过程,将照护对象交付专业急救人员继续进行高级生命支持。

5.2.34.5 如有条件，应设法取得 AED（自动体外除颤器）和简易人工呼吸器，并按要求进行操作。转移体位时，应保持头、颈、脊柱整体转移。抢救人员感到疲劳时应及时换人持续进行。抢救过程中，按压力量不宜过强，气量不宜过大，每次按压时间不宜过长，以免造成损伤。

6 生活照料服务内容及要求

6.1 饮食照料

6.1.1 照护人员应安排相对固定的时间、地点及餐桌位置，就餐环境应整洁安静，根据不同照护对象的病情要求准备相应的饮食，并协助其用餐。

6.1.2 对有咀嚼和吞咽功能障碍的照护对象，应采取切碎、搅拌食物等方法实施喂食。

6.1.3 应保持正确的喂食姿势，照护人员位于照护对象侧面，并与照护对象视线在同一水平线上。

6.1.4 应控制一口量及喂食速度、总进食量及食物温度。

6.1.5 每次喂食前应先协助照护对象进汤或水，通过胃管进食时应先检查胃管是否在胃内再确定喂食。

6.1.6 协助喂食时应动作轻柔，让照护对象有充分时间咀嚼吞服，防止呛咳或噎食。

6.1.7 喂食完毕后应给予照护对象漱口或清洁口腔，保持喂食体位 30min，防止呕吐与误吸。

6.1.8 通过胃管进食护理参照本标准 5.2.16。

6.1.9 失智照护对象存在食物认知障碍、拒绝进食时，应充分了解其饮食习惯，耐心帮助其养成三餐规律进食习惯。

6.1.10 照护人员应熟练掌握噎食急救方法。

6.2 排泄照料

6.2.1 床上使用便器

6.2.1.1 应根据照护对象的生活自理能力及活动情况，准备并检查便器，便器表面应无破损裂痕等，应保护照护对象隐私并注意保暖。

6.2.1.2 应采取合适体位，置入便器动作轻柔，避免硬塞硬拽。

6.2.1.3 便后应观察排泄物性状及尾骶部位的皮肤情况，保持肛周皮肤及床单位清洁、干燥，如发现异常应及时报告上级护理人员或医生。

6.2.1.4 便器使用后，应即时倾倒，定期消毒。

6.2.2 更换一次性肛袋

6.2.2.1 应评估照护对象造口大小及周围皮肤情况。观察便袋，当便袋有渗漏或便袋内容物超过三分之一时，应进行更换。用物应准备齐全。

6.2.2.2 应协助照护对象取平卧位、半坐卧位或坐位。注意保暖及遮挡。

6.2.2.3 操作时应揭去原有的便袋，应一只手按皮肤，另一只手由上往下撕，以免扯伤皮肤；用温水清洁造口及周围皮肤，用软纸轻轻擦干，确保皮肤干燥，不应使用酒精等刺激性强的外用药擦；粘贴便袋时，应先除去胶片外面的粘纸，贴于造口位置，轻压便袋胶片环及其周围，使其与皮肤充分接触紧贴，防止渗漏。

6.2.2.4 操作后应及时撤离污物，做好记录，发现异常情况应及时报告。

6.2.3 更换一次性尿袋

6.2.3.1 应评估照护对象病情，尿管通畅情况，检查导尿管无滑脱。用物准备齐全。严格执行无菌操作技术原则。

6.2.3.2 应暴露尿管和尿袋引流管接口，在尿管和尿袋引流管接口处铺治疗巾。关闭尿袋放尿端口。打开引流管开关，观察尿液引流通畅；用止血钳夹住留置导尿管开口上端 3-5cm 处；夹闭尿袋引流管开关。取下新尿袋引流管端口盖帽，放在治疗巾上。断开尿管和引流管接口，尿管末端向上，用左中指和无名指捏住。右手捏住换下引流管端口下端，左手将新引流管盖帽套在换下引流管端口上，松开右手，引流管放在床边。消毒尿管外口，连接尿管和新引流管端口，旋紧。松开止血钳，观察尿液引流通畅；夹闭尿袋引流管开关。固定新尿袋。

6.2.3.3 应每 2 小时放尿一次。记录尿液颜色、性状、尿量、尿袋更换时间；发现异常及时报告医护人员。操作全过程尿袋应始终低于照护对象会阴部位，避免尿液反流。

6.2.4 肠胀气、便秘护理

6.2.4.1 应评估照护对象是否存在肠胀气、便秘或粪便嵌塞等情况。

6.2.4.2 应首先选择物理方法进行协助排气、排便如按摩、热敷腹部等。

6.2.4.3 物理方法失败可使用开塞露协助排便、人工排便等。

6.2.4.4 必要时由医护人员采取灌肠、药物等处理方法。

6.2.5 人工取便

6.2.5.1 应评估照护对象的肛周皮肤、有无痔疮、便秘严重程度和通便药物的使用后情况及用药反应等。人工取便用物准备齐全，注意保护隐私，必要时注意保暖。

6.2.5.2 应协助照护对象应左侧卧位于床上。应右手带手套，右手食指涂肥皂液等润滑剂润滑。由浅入深，手法轻柔，操作过程中应注意观察照护对象的神志、面色。

6.2.5.3 操作后应及时做好照护对象肛周清洁，适当通风，避免对流风。

6.2.6 失禁护理

6.2.6.1 应评估照护对象的失禁情况，准备相应的物品。保护照护对象隐私，必要时注意保暖。尊重理解照护对象，给予安慰、开导和鼓励，帮助其树立恢复自行排尿、排便的信心，积极配合治疗和护理。

6.2.6.2 应用温水清洗局部皮肤，勤换衣被，保持身体清洁干爽，根据局部皮肤情况涂保护膜或油膏，应定时按摩受压部位，防止褥疮发生。必要时应用接尿装置进行体外引流尿液，男性可采用尿套，女性可采用尿垫、接尿器。大便失禁者，应观察了解其排便时间、规律，适时给予便盆，试行排便以帮助建立排便反射。应保持床单位清洁、干燥。

6.2.6.3 应鼓励并指导照护对象进行膀胱功能、盆底肌及肛门括约肌的训练，重建正常排尿、排便功能。如属于压力性尿失禁，应积极预防和治疗咳嗽等，尽量避免打喷嚏、大笑等以免引起腹内压

升高。

6.2.6.4 对室内有特殊异味的应适时开窗通风。在病情允许的情况下，应指导照护对象摄入足够的液体和营养。

6.2.6.5 对长期尿失禁的照护对象，应由医护人员采取留置尿管等护理措施。

6.2.7 失智照护对象的排泄护理

6.2.7.1 应评估失智照护对象一般情况，通过沟通、观察掌握其排便习惯和规律。经评估，其行走状态良好、情绪稳定、有排便需求时，协助其到卫生间排便。

6.2.7.2 应协助失智照护对象识别卫生间、如厕、清洁。告知其如厕流程，必要时可通过粘贴醒目标志等方式帮助其识别并加强记忆。

6.2.7.3 应帮助失智照护对象养成定时排便的习惯，建立到卫生间排便的意识，应按照护需求计划饮水量和时间，按时提醒其到卫生间排便。

6.2.7.4 操作全过程要体现耐心、尊重和人文关怀，注意保护隐私和安全。

6.3 清洁照料

6.3.1 面部清洁

6.3.1.1 应评估照护对象局部皮肤情况、配合程度等，准备面部清洁用物，水温应适宜，尊重照护对象的个人习惯。

6.3.1.2 擦洗眼部时，应由内眦至外眦擦洗；擦洗面部时，应按前额、面颊、鼻翼、耳后、下颌、颈部的顺序进行。

6.3.1.3 清洁后，应做到颜面部干净，口角、耳后、颈部无污垢，鼻、眼部无分泌物，必要时涂抹润肤霜，防止干燥。擦洗动作应轻柔，毛巾、面盆专人专用。眼角、耳道及耳廓等褶皱较多部位应重点擦拭。

6.3.2 梳头

6.3.2.1 应评估照护对象一般情况、配合程度等，准备梳头用物，选择圆钝的梳子，专人专用。

6.3.2.2 梳理短发时，应从发根梳至发梢；梳理长发时，应从发梢至发根逐段梳理。动作应轻柔。

6.3.2.3 应鼓励照护对象每天多梳头，以改善头部血液循环。

6.3.2.4 梳理脱落的头发，应及时清理并包裹好，丢在指定的污物袋内。

6.3.3 剃须

6.3.3.1 应评估照护对象局部皮肤状况、配合程度等，准备剃须用物。

6.3.3.2 选用电动剃须刀时，应按从左至右，从上到下，先顺毛孔，再逆毛孔的顺序，进行剃须。选用普通剃须刀时，应用剃须膏或温热毛巾敷脸，软化胡须，剃须时一手绷紧皮肤，一手握住剃须刀柄进行操作。剃须后应用温水擦拭干净，适当涂抹润肤油，及时清理用物。

6.3.3.3 忌剃须过短，避免胡须向皮内生长形成倒须，导致 “剃刀肿块”。

6.3.4 床上洗发

6.3.4.1 应评估照护对象一般情况，病情不稳定时不宜进行洗发。评估环境温湿度适宜，关闭门窗。准备床上洗发用物。

6.3.4.2 放置洗头器，应控制水温 38℃～40℃，耳朵应塞入不吸水棉球，操作者用前臂内侧试温后，用水杯等容器倾倒少量温水浸湿头发。

6.3.4.3 使用洗发液（膏），应由发际向头顶部用指腹揉搓头皮及头发，力量适中，避免抓伤头皮。

6.3.4.4 应注意观察照护对象面色、脉搏、呼吸等情况，操作中应适时询问照护对象，如有异常应停止操作并及时报告上级护理人员或医生。

6.3.4.5 洗净后应擦干或吹干头发，防止受凉。洗发过程中应注意防止水流入眼睛及耳朵。

6.3.5 指/趾甲护理

6.3.5.1 应评估照护对象生活自理能力、个人生活习惯、有无糖尿病等，选择合适的指甲刀。

6.3.5.2 操作时，应动作轻柔，防止皮肤破损。应注意指/趾甲的长度，不可过短，以免造成嵌甲，避免损伤甲床及周围皮肤。修剪后指（趾）甲边缘应用锉刀轻磨。

6.3.5.3 应经常查看照护对象指甲情况，适时进行护理，保持清洁、无长指（趾）甲。如有灰指甲等，应由具备一定专业的人员进行处理。修剪过程中，不可损伤皮肤，尤其对有糖尿病等情况，应特别注意，一旦损伤皮肤，应及时进行处理并报告医生。操作结束后，应及时整理用物，指甲碎屑等应用纸巾包裹丢入垃圾桶内。

6.3.6 手、足部清洁

6.3.6.1 应评估照护对象手足部局部皮肤情况、配合程度等。根据情况准备清洁用物，洗手、洗脚用具应分开专用，即时清洗。

6.3.6.2 如局部皮肤无破损时应将手、脚放入调节好水温的脸盆或水桶中充分浸泡。用适量肥皂或洗手液等细致擦洗，去除手脚部污垢或死皮，动作轻柔。注意指/趾缝的清洗。

6.3.6.3 应尊重照护对象的个人习惯，必要时涂抹润肤霜，防止皮肤干燥。

6.3.7 口腔清洁

6.3.7.1 应评估照护对象的生活自理能力、意识、身体状况，查看口腔有无牙龈出血、有无溃疡、有无义齿等，根据病情选择合适的清洁方式，准备清洁用物。

6.3.7.2 应鼓励并协助意识清醒者漱口，上肢功能良好者自行刷牙。指导照护对象正确的漱口方法，避免呛咳或者误吸。

6.3.7.3 对不能自理的照护对象应由照护人员进行口腔护理，具体操作要求见本标准 5.2.17。

6.3.8 会阴护理

6.3.8.1 应评估照护对象局部皮肤情况，环境温湿度适宜，关闭门窗。准备用物。

6.3.8.2 应协助照护对象取合适体位。女性应由阴阜向下至尿道口、阴道口、肛门，边擦洗边转动毛巾。清洗毛巾，分别擦洗两侧腹股沟部位。男性由尿道外口、阴茎、阴囊、腹股沟和肛门顺序擦洗。擦洗用水的温度应为 40℃～45℃。

6.3.8.3 操作时动作应轻柔，注意保暖，保护隐私。

6.3.9 床上擦浴

6.3.9.1 应评估照护对象一般情况、病情、配合程度等，环境温湿度适宜，关闭门窗，准备用物，根据其耐受程度及季节因素等调节水温，根据需要协助提前排尿排便，注意保暖和保护个人隐私。

6.3.9.2 盆内倒入温水三分之二满，调节水温至 38℃～40℃，协助照护对象取合适体位，依次擦洗面部、颈部、上肢、胸腹、背臀、下肢、足部、会阴。

6.3.9.3 擦浴过程中，应适时换水；随时观察病情变化及皮肤情况，应尽量减少暴露，如出现寒颤、面色苍白、脉速等现象应立即停止操作，给予适当处理，及时报告上级护理人员或医生；擦洗女性乳房部位时，应环形用力，并注意擦净乳房下皮肤皱褶处；擦洗会阴部时，应换盆、换水、换毛巾；注意保护伤口，妥善固定各种管路。

6.3.9.4 毛巾、脸盆应专盆专用，用后及时清洗备用。

6.3.10 沐浴

6.3.10.1 参见本标准 6.3.9.1。

6.3.10.2 选择合适的沐浴方式（淋浴或盆浴），病情不稳定时禁忌沐浴。

6.3.10.3 沐浴前应根据照护对象耐受程度及季节因素，调节水温至 38℃~40℃，先开冷水，再开热水。沐浴过程中注意水温变化。如需再次调节时，应避开照护对象身体调节。

6.3.10.4 沐浴时应取舒适、稳固的座位，肢体处于功能位，先面部后躯体，沐浴过程中注意观察照护对象身体情况，发现异常及时处理，防止烫伤、跌倒、着凉。

6.3.10.5 沐浴前应适当饮水，防止脱水；避免空腹或饱餐时沐浴；沐浴时忌突然蹲下或站起；沐浴时间不宜过长；沐浴后应身体无异味、无污垢；沐浴后应及时清理浴室及用物，通风换气，居室内避免对流风。

6.4 更换衣物

6.4.1 应评估照护对象一般情况、肢体功能和配合程度等，准备清洁衣物。

6.4.2 脱衣时，应先脱近侧，后脱远侧；穿衣时，应先穿远侧，后穿近侧。如有肢体活动障碍，应先脱健侧，后脱患侧；先穿患侧，后穿健侧。

6.4.3 应保持肢体在功能位范围内活动，避免拉拽，防止肌肉损伤或骨折。

6.4.4 应根据照护计划更换衣服，必要时随时更换。要尊重照护对象意愿并保护隐私。

6.5 协助更换体位

6.5.1 应评估照护对象营养状态、身体受压部位皮肤情况、配合程度等。

6.5.2 应协助照护对象侧卧位，注意让其用健侧肢体一起用力更换体位。应保护患肢和皮肤，翻身时避免拖、拉、拽、推，以免挫伤皮肤或引起骨折。

6.5.3 更换体位时应注意检查背、臀部皮肤情况，必要时进行擦洗，保持局部清洁干燥。

6.5.4 一般情况下应每 2 小时翻身一次，必要时 1 小时翻身一次。更换体位后，记录翻身时间、体位、皮肤情况等，发现异常及时报告。

6.6 协助肢体被动活动及指导

6.6.1 应评估照护对象神志、病情、活动能力、活动意愿等。按照被动活动计划，选择相应的方法协助照护对象进行肢体被动活动。

6.6.2 操作前，应做热身运动；操作时，应嘱照护对象放松肢体肌肉，双手固定关节近端，活动关节远端，病情允许时，应尽量作关节各方向的全幅度运动，动作要轻柔、准确，避免粗暴，防止损伤，每天 2～3 次，每次 20～30min；操作后，应做整理运动，将照护对象肢体轻轻抖动、从远心端向近心端轻轻拍打，放松肌肉，促进血液回流，使肢体逐步恢复到安静状态。热身及整理运动一般为 6～10min。

6.6.3 照护人员应提前做好周密的被动活动计划，向家属传授被动活动的相关知识，鼓励家属积极参与。对病情稳定者，应尽早协助进行被动肢体锻炼，促进功能恢复，防止肌肉萎缩和关节挛缩，避免“废用综合征”。

6.7 整理床单位

6.7.1 应评估照护对象一般情况、配合程度等，室温适宜，酌情关闭门窗，准备用物。

6.7.2 松开一侧床单，扫净床上渣屑，并逐层拉平铺好，同法整理另一侧。整理盖被，拍松枕头。

6.7.3 应每日进行床单位的清扫擦拭，保持床铺的清洁、干燥、平整、柔软、舒适。床单被套等用物污染时，应随时更换送洗。

6.7.4 床单、被套应每周定期更换。被褥应经常在太阳下暴晒，以保持清洁、干燥、松软。进食时不应整理床单位。

6.8 居室消毒

6.8.1 应评估照护对象一般情况、配合程度等，根据情况选择消毒液消毒法或紫外线灯照射消毒法，根据消毒方法准备用物。

6.8.2 选用消毒液消毒时，应严格按照浓度要求进行配置。配置消毒液时，照护人员应戴好口罩和手套，对金属有腐蚀的消毒液，不应使用金属容器配置盛放，易分解的消毒液应现配现用。

6.8.3 选用紫外线灯照射消毒时，定期检查紫外线灯的使用情况，每次使用应记录紫外线灯照射时间，从灯亮后 5-10min 开始计时，如有特殊情况需要中断消毒，再次消毒时需重新计时。紫外线穿透力弱，被消毒的物品不能有任何遮盖，照射距离不应超过 2 米。照射过程中，应保护照护对象的皮肤和眼睛，必要时应戴眼罩。紫外线灯管累计使用时间超过 1000 小时，应及时更换新管。

6.8.4 物品和空气消毒应有记录。居室应保持清洁、卫生，定时通风。

6.9 睡眠照料

6.9.1 应评估照护对象意识、精神、心理、情绪、有无失眠等情况；影响睡眠的因素，包括室内环境、晚餐时间及食品、大小便等；引起生理不适的原因，包括疼痛、恶心、呕吐、咳嗽、饥饿、口渴、姿势与体位、个人卫生、物理环境等方面。布置舒适睡眠环境，保持安静、温度适宜，光线适宜。必要时准备相应的用物。

6.9.2 照护人员轻敲房门后进入房间，协助关窗，调节温湿度，检查床铺有无渣屑、软硬度，调整床铺高度，被褥松软适中，展开被褥，平整铺床，按照护对象习惯调整枕头高度及软硬度，去除身体刺激源，控制疼痛，必要时按医嘱用药。协助上床就寝，盖好盖被，及时满足其适当需求。保持适当的姿势和体位，调节光线，最低睡眠时间每日不少于 6 小时。

6.9.3 应按要求巡查照护对象睡眠情况，如患者入睡困难，可对症处理。对不能解决的睡眠障碍应及时报告上级护理人员或医生。逐步培养照护对象规律睡眠习惯。

6.9.4 照护睡眠异常、行为失控的失智照护对象，应有耐心，操作全过程应体现尊重和人文关怀，尽量顺从照护对象，对其反常行为不可强迫改变，避免加重异常行为，应注意保护其安全，导致其自伤或伤人。

6.10 护理安全照料

6.10.1 应评估照护对象的病情、活动能力、环境等，持续动态评估其认知反应、心理状态、肢体活动、配合程度，存在的安全隐患。根据情况准备用物。

6.10.2 应根据照护对象的病情、活动能力等需要使用保护用具保证其安全。对因虚弱意识不清或其他原因，导致容易坠床、撞伤、抓伤等意外者，应选用床档、约束带等措施进行保护。使用约束带时，应告知家属并征得同意，手腕部或踝部应用棉垫包裹，松紧度适宜，肢体处于功能位，保护期间应定时放松，及时了解观察肢体血运状况。

6.10.3 应加强巡视和观察，积极预防坠床、跌倒、压疮、脱管、烫伤、误吸、误食、错服药物、走失等意外的发生。应及时对保护用具进行检查维修，保证使用安全。

7 康复与功能维护内容及要求

7.1 语言训练

7.1.1 应评估照护对象身体状况、疾病程度、言语障碍等情况。准备用物。

7.1.2 应选择干净整齐、温湿度适宜、安静的环境，避免噪音。

7.1.3 应根据评估情况，选择适合照护对象的言语训练方案。具体操作要求如下：

a)语音训练：照护人员示范，让照护对象模仿发音。

b)听理解训练：照护人员讲出物品的名称，照护对象通过卡片或实物指出正确的物品。

c)口语表达训练：鼓励多讲话，通过听单词或句子，进行复述。

d)阅读理解和朗读训练；鼓励照护对象阅读和朗读。

e)书写训练：鼓励照护对象读出物品名称，逐渐抄写单词、句子或文章。

7.1.4 应每次训练 30min。每日 1～2 次。应随时观察照护对象反应及其感受，发现异常立即停止。应鼓励家属了解言语康复训练的意义、计划、方案并积极参与。

7.2 吞咽训练

7.2.1 应选择干净整齐，安静，温湿度适宜的环境。与照护对象及家属沟通，了解既往进食和呛咳情况。评估照护对象的身体状况及吞咽障碍程度。准备用物。应在康复医生指导下，进行直接或间接吞咽训练。

7.2.2 饮食指导直接训练方法具体操作要求如下：

a）卧位训练：应取 30 度仰卧位，偏瘫侧肩部以软枕垫起，身体倾向健侧 30 度，头部前屈，长照照护人员应位于照护对象健侧协助进食，利于食物向舌部运送，减少逆流和误咽。

b）坐位训练：照护对象应取坐位，头稍前屈位，使舌骨肌的张力增高，喉上抬，食物容易进入食道。如果头部能转向瘫痪侧 80 度，可以使健侧咽部扩大，便于食物进入，防止误咽。

c）食物选择：应根据吞咽障碍的程度及阶段，按照先易后难的原则，选择容易吞咽的食物，如密度均匀、有适当黏性、不易松散、通过咽及食管时容易变形、不会在黏膜上残留的食品。

d）一口量选择：正常人一口量约为 20ml。开始训练一般先以 3∽4ml 试之，然后酌情增加。注意选择餐具以薄而小的汤匙为宜。

7.2.3 吞咽功能间接训练常用方法具体操作要求如下：

a）咽冷刺激训练。应使用棉棒蘸少许冰冻的水，轻轻刺激照护对象软腭、舌根及咽后壁，然后嘱做空吞咽动作。寒冷刺激能有效地强化吞咽反射，应提高口腔黏膜的感受性

b）吸吮训练。应嘱照护对象食指戴上胶套，放于口中，模仿吸吮动作，体验吸吮的感觉，每次吸吮 20 次。

c）屏气一发声训练。照护对象应坐在椅子上，深吸气后屏气，双手支撑椅面用力按压，此时胸廓固定、声门紧闭；然后，突然松手，声门打开，发出呼气声。以训练声门的闭锁功能、强化软腭的肌力而且有助于除去残留在咽部的食物。

d）体位的调节训练：应选择能预防咽部残留物进入气道的坐位进食。

e）反复吞咽训练：一口食物多次吞咽或空吞咽。

f）轮换吞咽训练：固体和液体食物交替吞咽，利于除去咽部残留物。

g）健侧吞咽训练：将食物放于健侧吞咽。

h）转头吞咽训练：左右转头吞咽，有利于清除两侧梨状隐窝残留食物。

i）点头样吞咽训练：先将头后仰，随后头向前低，同时做吞咽动作，以利于清除会厌部残留食物。

j）促进吞咽反射训练：用手指沿甲状软骨到下颌上下摩擦皮肤，通过吞咽肌群的感觉，诱发吞咽反射。

k）咳嗽训练：嘱照护对象努力咳嗽，建立排除气管异物的防御反射。一般训练 2 周后，待吞咽功能明显好转，再进行摄食训练。

7.2.4 训练过程中应询问照护对象有无不适，再重复进行训练动作，持续训练 30min。随时观察照护对象反应及其感受，发现疲劳、呛咳立即停止。训练时要严密观察，避免发生窒息，如有意外立即急救。

7.2.5 训练完毕，应协助照护对象取舒适体位，进行休息。

7.3 床上移动训练

7.3.1 桥式运动功能训练

7.3.1.1 环境干净整齐、安全、温湿度适宜。全面评估照护对象的神志、病情、活动能力、意愿等。了解照护对象生活习惯，避开进餐及休息时间。

7.3.1.2 应协助照护对象排尿后平卧于床上。循序渐进，持之以恒，每天训练 2～3 次，每次不超过 30min。具体操作要求如下：

a)双桥运动训练：协助照护对象取仰卧位，两腿屈髋屈膝，使小腿与床面呈 90 度，双脚平放在床上，以脚掌与健侧手掌共同支撑，慢慢将臀部抬起，保持 5～10 秒后，再慢慢放下。训练时两腿之间可以夹持枕头或其它物体。发现照护对象力量不足，不能保持臀部抬起 5～10 秒时，可用双手置于照护对象臀下轻轻托扶，让照护对象慢慢适应。

b)单桥运动训练：协助照护对象取仰卧位，患侧下肢屈髋屈膝，使小腿与床面呈 90 度，脚掌平放于床面与健侧手掌共同支撑，将臀部抬离床面，健侧下肢伸展、悬空或搭于患肢股骨远端，保持 5～10 秒后，慢慢放下。发现力量不足，不能保持臀部抬起 5～10 秒时，可用双手置于照护对象臀下轻轻托扶，让照护对象慢慢适应。

7.3.1.3 训练一次结束后，应调整为平卧位，询问掌握情况，基本掌握后再开始下一次训练。询问无不适，再重复以上动作。

7.3.1.4 训练完毕，应协助取平卧位，进行休息。记录训练内容、时间、反馈情况。

7.3.1.5 应随时观察照护对象反应，及时擦净汗液，避免着凉。发现异常，应立即停止训练并报告医护人员。

7.3.2 从仰卧位至床边坐位的体位转换功能训练

7.3.2.1 环境干净整齐、安全、温湿度适宜。全面评估照护对象的神志、病情、活动能力、意愿等。了解照护对象生活习惯，避开进餐及休息时间。

7.3.2.2 协助照护对象侧卧位：应站在照护对象健侧，协助将头偏向健侧，用健侧手将患侧手放于胸腹前，用健侧下肢帮助患侧下肢屈曲，双足支撑于床面。右手扶托照护对象髋部，左手扶托颈肩部，协助整体翻身。

7.3.2.3 协助照护对象床边坐起：应指导照护对象健侧上肢置于床边，用肘关节屈曲支撑于床面上。协助照护对象肩部向上牵拉，利用健侧手掌支撑床面，抬起上身，用健侧下肢帮助患侧下肢旋转坐

于床边，两腿置于床下。协助调整舒适坐姿，用软垫支撑，坚持坐立。

7.3.2.4 协助照护对象躺下：照护对象感觉劳累时，应指导用双手支撑床面，旋转身体，用健侧肘关节支撑身体，使身体缓慢侧躺。双手扶托照护对象双肩，保持向后倾倒速度，缓慢完成侧卧，再将双下肢置于床上，再到仰卧位。整理床单位，盖好盖被，支起床挡。

7.3.2.5 转换过程中应随时询问照护对象感受，观察面色、表情，是否有头晕、恶心等，出现异常，立即停止，恢复卧位，必要时报告。

7.4 站立训练

7.4.1 在照护对象能够坐立、坐直、站稳的时候，应及时对进行站立训练。

7.4.2 应选择地面平整无障碍、温湿度适宜、安全的环境。尊重照护对象意愿，掌握活动能力，评估身体状况、疾病程度，与家属沟通，了解生活习惯。准备用物。

7.4.3 协助照护对象坐立：应协助照护对象侧卧，起床，转移在床边坐直、坐稳。与照护对象相对，坐在座椅上向照护对象示范。

7.4.4 向照护对象示范训练动作：照护人员应坐直，双膝关节呈 90 度，十指相扣握拳，两臂向前伸直 90 度。模拟健脚向椅子侧移动，膝关节呈 70～80 度，身体重心慢慢向前移。臀部抬离椅子，用模拟健侧下肢用力蹬住地面，带动患侧下肢站立、站稳。恢复坐位。与照护对象交流，询问是否理解训练动作。

7.4.5 协助站立：应协助照护对象在椅子上坐直、坐稳，双膝关节呈 90 度，十指相扣握拳，两臂向前伸直 90 度。协助照护对象健侧脚向后移动，膝关节呈 70～80 度，身体重心慢慢向前移。站在照护对象前面，保护，协助照护对象臀部抬离椅子，健侧下肢用力蹬地，带动患侧下肢站立、站直、站稳。与照护对象交流，无不适，恢复坐位，再次重复训练。

7.4.6 应随时询问照护对象感受，观察面色、表情，是否有劳累、头晕、恶心、心慌等。出现异常，立即停止，恢复坐位或者卧位，必要时报告。

7.5 轮椅转移训练

7.5.1 环境与准备工作

7.5.1.1 应选择整洁宽敞、无障碍物的环境。评估照护对象身体状况，确定照护对象具备转移能力。

7.5.1.2 准备轮椅，检查轮胎气压充足，刹车制动良好，坐椅、靠背、安全带、脚踏板、架腿布完好。

7.5.1.3 协助照护对象侧卧、坐立，穿好衣服和穿防滑鞋。

7.5.2 从床到轮椅转移

7.5.2.1 偏瘫者转移。轮椅应置于健侧，与床呈 30°～45°角，固定，协助照护对象从床上坐起，双足着地，健足在患足后方，健侧手抓住轮椅远侧扶手，健足蹬地起身，以健肢为轴，转动身体坐到轮椅，调整位置，松刹车，慢慢离床。

7.5.2.2 双下肢瘫痪者转移。轮椅应直角对床，固定。照护对象背向轮椅在床上坐起，双手支撑向轮椅靠近，抓住轮椅扶手，臀部坐入，调整位置，松开刹车，慢慢离床，再次固定轮椅、放双足于踏板上，松开刹车，慢慢移动。

7.5.3 从轮椅到床转移

7.5.3.1 主动移动。应按健侧转移摆放轮椅，固定。照护对象用健侧脚抬起脚踏板，身体慢慢前移动，双足落地，健侧手按床，支撑身体前倾，用健侧下肢支撑患侧下肢站起，旋转身体坐到床边，

调整位置，移开轮椅，用健侧带动患侧将双足移到床上。

7.5.3.2 被动移动。固定轮椅应与床呈 30°～45°角，，长照照护人员与照护对象相对，用脚支起脚踏板，调整照护对象坐在轮椅边。一脚向前，伸入照护对象两腿中间，一脚向后，双膝半蹲位站稳，双手托住照护对象两侧腋下，用双腿力量直立，将照护对象扶起。转移重心，使照护对象臀部座至床边，向床中心移位、侧卧、双足移到床上、平卧。

7.5.4 转运过程

转运过程中，应询问照护对象感受，指导使用轮椅方法，及时改进操作方法，如有不适及时停止操作。转运全过程，要加强保护，避免坠地或跌到。

7.6 行走训练

7.6.1 应选择地面整洁、平坦、无积水的环境。评估照护对象的身高、体重、年龄、病情、手杖使用情况、活动能力等情况。为照护对象准备合体的着装，鞋子防滑。准备四脚手杖、安全腰带等用物。检查手杖把手、橡胶垫、调节高度和方向的按钮完好。

7.6.2 应为照护对象系好保护腰带，用健侧手握住把手，放在健脚外侧 15 公分处，身体直立，目视前方。具体操作要求如下：

a)三点式行走：先手杖、再患侧、再健侧。照护人员站在患侧保护。

b)二点式行走：先手杖和患脚、再健脚。照护人员站在患侧保护。

c)上楼梯行走：先上健脚，再上拐杖，再上患脚行走，照护人员站在患侧后方保护。

d)下楼梯行走：先下拐杖，再下患脚，再下健脚。照护人员站在患侧前面保护。

7.6.3 行走过程中，应观察有无障碍物，及时清理。观察、询问照护对象感受，如有不适，立刻休息。

7.6.4 行走结束，应了解照护对象使用手杖感受，使用中存在的问题，并指导解决。

7.6.5 行走全过程应加强保护，避免拉、拽照护对象胳膊，以免在站立不稳或意外跌倒时发生骨折。

7.7 认知能力训练

7.7.1 应选择照护对象熟悉的环境。全面评估照护对象身体状况，疾病情况。与照护对象及其家属沟通，了解生活习惯。提前处理喝水、加餐、大小便等需求。准备用物。

7.7.2 应根据评估结果选择不同的训练方法，具体操作要求如下：

a)记忆和注意力训练：将一串不按顺序排列的数字，念给照护对象复述，直至不能复述为止。给照护对象观看几件物品，由少到多，逐渐增加，观看时间可由长到短。

b)计算力训练：将物品分成两堆，让照护对象比较哪堆多或少。进行简单的消费账目计算。

c)思维能力训练：让照护对象把动物、植物图画卡片分门归类，训练思维和综合分析能力。

7.7.3 应以缓慢温和的语速告诉照护对象每一项操作的步骤。把每一步的具体动作加以分解。反复示范指导照护对象练习。多用表情和手势，得到照护对象反馈后再开始下一步。

7.7.4 训练过程中应观察反应，发现异常立即停止。

7.8 日常生活能力训练

7.8.1 应评估照护对象的日常生活自理能力。

7.8.2 应合理布置照护对象房间环境，将床、椅及所有生活用品放在适当的位置。

7.8.3 应协助照护对象完成进食、个人卫生、穿脱衣裤鞋袜、如厕等日常生活自理能力训练，提高生活质量。

7.8.4 训练时应让照护对象处于舒适的位置，照护人员处于可以清楚地观察照护对象活动全过程的位置。发布指令应缓慢、耐心，逐步讲解过程，强调要点，及时纠正错误动作。活动量应逐渐增加，掌握时间，不使照护对象过度疲劳。

7.9 肢体摆放及指导

7.9.1 环境与准备工作

应选择室内整洁、温湿度适宜的环境，关闭门窗。评估神智、病情、肢体活动情况。提前穿衣、喝水、排便等。准备用物。

7.9.2 协助健侧位摆放

7.9.2.1 照护人员应站在床右侧中间位置，两腿打开同肩宽，依靠床边。放下右侧床档，打开盖被，“S”型折叠对侧。

7.9.2.2 应协助将左侧手放于胸腹前。嘱照护对象屈曲右下肢，用右侧手掌和右侧脚掌支撑床面，照护人员面向床头，右手在照护对象左侧、左手在右侧，环抱照护对象双肩部，协助向对侧移位。照护人员面向床尾，左手在照护对象左侧，右手在右侧，环抱照护对象臀部，协助向对侧移位；双手协助双下肢向对侧移位；操作过程中可分别扇形拉开被尾和被头一角，分别遮盖照护对象身体上下部分保暖。

7.9.2.3 应嘱照护对象头部转向右侧，支起双膝关节，右手放在照护对象左髋部，左手放在左颈肩部，协助向右侧整体翻身至床中线位置。

7.9.2.4 应在照护对象右颈肩部垫软垫。左臂向前伸直，手心向下，臂下垫软垫。右上肢自主体位，腋下抱软垫。右腿向后伸，左腿向前屈曲 90 度，呈跨步式，在左右小腿下垫软垫，为膝部和踝部骨隆突处减压。保持体位舒适稳定。

7.9.3 协助平卧位摆放

7.9.3.1 照护人员应站在床右侧中间位置，两腿打开同肩宽，依靠床边。放下右侧床档，打开盖被，“S”型折叠对侧，撤去各部位软枕。

7.9.3.2 应协助照护对象伸直左下肢，嘱照护对象面向天花板，屈曲右下肢。右下足侧向床边，右手掌与右脚掌平放于床面，用力带动患侧肢体，向左侧翻身，摆放平卧位。

7.9.3.3 应嘱照护对象继续用右侧支撑，带动患侧肢向右移位至床中间位置。

7.9.3.4 应为照护对象双肩部及双膝下垫软垫，使双肩持平并为双足跟减压。

7.9.4 协助患侧位摆放

7.9.4.1 照护人员应站在床左侧中间位置，两腿打开同肩宽，依靠床边。放下左侧床档，打开盖被，“S”型折叠对侧，撤去软垫。

7.9.4.2 应协助照护对象用右侧手拉住右侧床档，屈曲右下肢，用右侧脚掌支撑床面，向右侧移动身体。照护人员面向床头，左手在照护对象右侧、右手在左侧环抱照护对象双肩部协助向对侧移位。照护人员面向床尾，左手在照护对象左侧，右手在右侧，环抱照护对象臀部向对侧移位。双手协助双下肢向对侧移位。操作过程中可分别扇形拉开被尾和被头一角，分别遮盖照护对象身体上下部分保暖。操作过程中可扇形拉开盖被一角分别遮盖照护对象身体上下保暖。

7.9.4.3 应嘱照护对象头部转向左侧，用右侧下肢带动左侧下肢屈曲双膝关节，右足部外展，脚面平放于床面，嘱照护对象右手抓住左侧护栏，用力向右侧翻身至床中线位置。

7.9.4.4 应在照护对象右颈肩部垫软垫。左臂向前伸直，手心向上，臂下垫软垫。右上肢自主体位，

腋下垫软垫。左腿向后伸，右腿向前屈曲 90 度呈跨步式。左右小腿下垫软垫，为膝部和踝部骨隆突处减压。保持体位稳定舒适。

7.9.5 注意事项

7.9.5.1 每摆放一种体位后，应将衣裤整理平整，盖好盖被，折好被筒，支起床挡。记录指导时间、体位、照护对象反应。异常情况及时报告。指导中注意照护对象健侧肢体的自主活动。避免拖、拉、拽、推，以免挫伤皮肤或引起骨折。

7.9.5.2 指导照护对象家属时，应示范操作步骤，指导家属重复操作，告知注意事项。

7.10 翻身训练及指导

7.10.1 应干净整齐、温湿度适宜。了解照护对象的身体状况，疾病程度，生活习惯。评估照护对象神智、病情、健侧肢体的肌力程度。提前穿衣、喝水、排便等。准备用物。

7.10.2 应协助照护对象仰卧位。协助照护对象头转向一侧，用健侧手握住患侧手，患手拇指压在健侧拇指上，双上肢前伸 90 度，指向天花板，健侧下肢屈髋屈膝。协助健侧脚插入患侧腿的下方钩住患肢的踝部。

7.10.3 应协助照护对象用健侧上肢的力量借助惯性动作，带动患侧上肢左右摆动 2～3 次。在身体摆动同时，利用健侧膝部的力量带动患侧身体翻向健侧或患侧。再调整为平卧位。

7.10.4 训练照护对象向健侧翻身时，照护人员应站在右侧床边保护。向患侧翻身时，照护人员站在左侧床边保护。

7.10.5 应询问照护对象掌握情况，基本掌握后，再开始下一次训练。询问照护对象无不适后，方能再重复以上动作。根据照护对象状态，循序渐进，确定每天训练 2～3 次，每次不超过 30min。

7.10.6 训练完毕，应协助照护对象取平卧位，进行休息。

7.10.7 训练中应随时观察照护对象反应，及时擦汗，避免着凉。发现异常，应立即停止训练并报告医护人员。

7.10.8 指导照护对象家属时，应示范操作步骤，指导家属重复操作，告知注意事项。

7.11 叩背排痰指导

7.11.1 应向照护对象家属示范扣背排痰操作，操作要求见本标准 5.2.12。

7.11.2 应指导家属重复操作。观察照护对象反应、家属学习状态，发现异常及时纠正。

7.11.3 指导过程应密切观察病情变化，发现异常立即停止并报告。

7.12 预防压疮指导

7.12.1 应评估照护对象精神、营养、活动状态及身体受压部位皮肤情况。选择室内整洁，温湿度适宜的环境。关闭门窗。准备用物。

7.12.2 应向照护对象及其家属解释操作方法，取得配合。边讲解边示范。

7.12.3 应协助照护对象身体取得侧卧位。暴露照护对象背部，检查背臀部皮肤情况，将浴巾半铺半盖在照护对象背部。准备约 38～40℃温水，用温热毛巾从照护对象骶尾部沿脊柱向上擦至第七颈椎，再分别从上向下螺旋擦拭双侧背臀部并用浴巾沾干。保持体位 1～2 小时恢复平卧位，观察反应 1～2 小时，再次向另一侧侧翻身。

7.12.4 应询问家属掌握情况，必要时应再次示范讲解。

7.12.5 应防止局部长期受压，对骨粗隆部位皮肤要认真检查。护理过程中应注意保暖，避免受凉。避免拖、拉、拽、推，防止挫伤照护对象皮肤，经常为照护对象修剪指甲防止自伤。便器等护理用

具应完好，避免因刮伤、蹭伤引起压疮。已经发生压疮的部位禁止推拿、按摩。

6.12.6 应鼓励照护对象尽量做力所能及的床上活动，促进静脉回流，预防压疮发生。应提醒家属保持局部干燥，避免因潮湿引起或加重压疮。指导家属注意饮食营养，改善照护对象营养状况。

7.13 预防噎食吞咽障碍指导

7.13.1 应向照护对象家属讲解预防噎食吞咽障碍的相关知识，吞咽训练操作要求见本标准 7.2。

7.13.2 应注意选择指导时间，观察照护对象反应、家属学习状态，发现异常及时纠正。

7.13.3 指导过程应密切观察病情变化，发现异常立即停止并报告

7.14 预防跌到、坠床、烫伤指导

7.14.1 应向照护对象家属讲解预防跌倒、坠床、烫伤的相关知识，指导家属除加强日常照护以外，还应注意进行运动功能训练，以提高照护对象肌力和活动的灵活性，避免因活动不灵发生跌到、坠床和烫伤。

7.14.2 应检查照护对象的生活环境设施，及时指导家属排除隐患。

7.14.3 应向照护对象家属讲解跌到、坠床、烫伤后应急处理相关知识。

8 其他照护服务内容及要求

8．1 药物管理和服用督导

8.1.1 应了解照护对象所用药物名称、剂量、途径、时间及不良反应等信息。遵医嘱用药。

8.1.2 应根据照护对象病情，选择适宜的喂服方式，当照护对象拒绝用药时，应耐心劝导，待其配合后再完成。

8.1.3 应向照护对象家属介绍用药相关知识、保管方法及注意事项等，指导照护对象家属掌握喂服方法。

8．2 陪同就医

8.2.1 应提前联系照护对象及家属，了解照护对象病情，确认时间、地点、交通方式、是否预约挂号等就医服务事项，询问是否需要轮椅、拐杖等辅助服务设备。签订服务协议。

8.2.2 应按约定时间、方式到达照护对象住所，接照护对象就医。提醒照护对象及家属携带就医资料和物品。

8.2.3 应协助照护对象办理就医手续，陪同照护对象就诊、检查、治疗等。陪同就医时，应协助照护对象陈述病情，记录医嘱；确认检查项目注意事项，取送检查结果；关注治疗进度，观察照护对象治疗反应，遇突发状况及时报告医护人员并告知家属。陪同就医期间应及时解决照护对象的生理和生活需求。

8.2.4 就医结束后，应按约定方式将照护对象送回住所，向家属告知医嘱及就医情况，交接就医资料、药品等物品。

8.3 健康生活指导和心理疏导

8.3.1 健康生活指导

8.3.1.1 应评估照护对象生活情况，了解照护对象的生活方式和习惯。

8.3.1.2 应告知照护对象及家属健康生活知识，引导和帮助其生活起居规律，饮食合理，卫生习惯良好，适当运动或参加康复训练，保证充足的是睡眠和休息，保持排泄通畅等。

8.3.2 心理疏导

8.3.2.1 应评估照护对象精神状态，了解照护对象存在或潜在的心理问题。

8.3.2.2 在照护服务过程中应积极与照护对象建立信任关系，运用语言、表情、肢体等心理疏导技巧，及时为照护对象提供心理疏导。

8.3.2.2 应引导照护对象积极参与形式多样的健康娱乐活动，丰富其精神文化生活。

8.3.2.4 应主动为安宁照护对象提供心理支持。